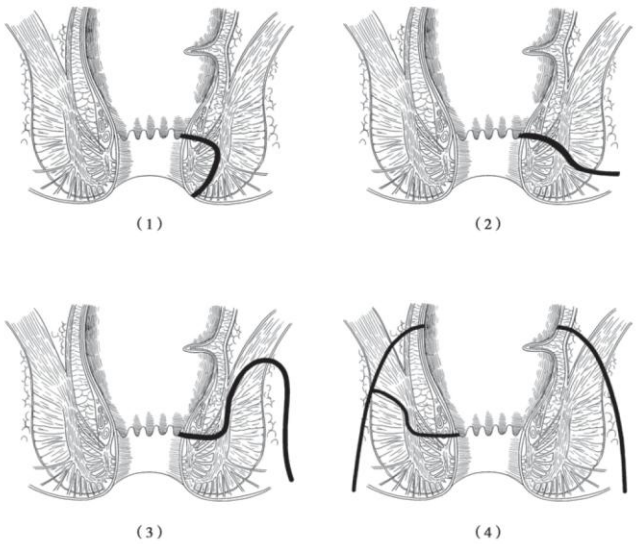


图 41-33　肛瘘的四种解剖类型

(1)肛管括约肌间型　(2)经肛管括约肌型　(3)肛管括约肌上型　(4)肛管括约肌外型

最常见

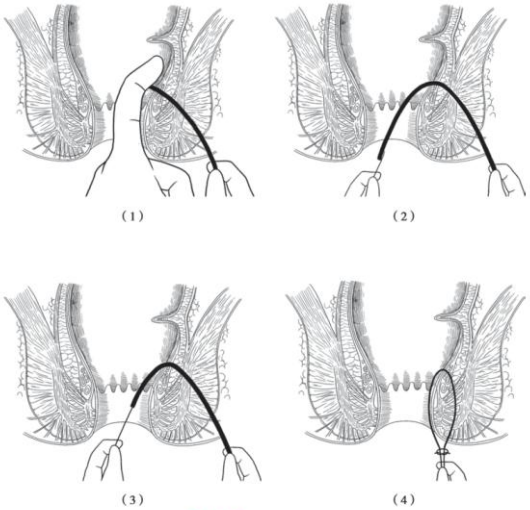


图 41-35　肛瘘挂线疗法

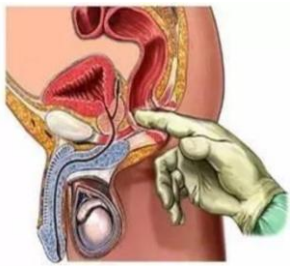
(1)用探针由瘘管外口探入内口,同时手指插入直肠或肛管内　(2)弯曲探针前端,将其拉到肛门口外　(3)探针前端缚一丝线,并拔上一橡皮筋　(4)退出探针,把橡皮筋经瘘管拉出,再根据需要行切割或引流挂线

依靠皮筋的机械作用使局部组织缺血坏死

专题串联 • 直肠指检

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

直肠癌	70%低位直肠癌触及不规则、质硬、易出血肿物
直肠息肉	柔软光滑、可推动的、有蒂、可出血肿物：内镜下切除息肉
痔	内痔：柔软的血管团　直肠指检摸出血不一定是直肠癌
肛瘘	条索状肿物
盆腔脓肿	波动感
前列腺相关疾病	前列腺增生（中间沟变浅或消失）、前列腺癌、前列腺炎等　所有前列腺相关疾病都首选直肠指检
肛裂	不用





真题解析 • 其它大肠与肛管疾病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2012N116-117 A 男性，36 岁，肛周持续性剧烈疼痛 2 天，局部有肿物突出，无便血。查体：肛周 1.0cm 直径的肿物，呈暗紫色，表面光滑，水肿，质硬有触痛。　便鲜血优先考虑肛裂、内痔

116.该患者最可能的诊断是

A.肛裂前哨痔

B.血栓性外痔

C.内痔脱出嵌顿　也可以痛